

1. До лікарні шпиталізовано пацієнта віком 47 років з діагнозом: політравма, відкрита черепно-мозкова травма, розрив печінки, закритий перелом обох стегнових кісток. Яку тактику лікування потрібно застосувати для цього пацієнта?

- A. Лікування внутрішніх органів
- B. Оперативне лікування переломів
- C. Стабілізація загального стану пацієнта
- D. Одночасне лікування всіх пошкоджень
- E. 'Damage control'

2. Внаслідок ДТП пацієнт отримав удар по нижній третині лівого стегна, після чого не міг встати. Клінічно визначаються достовірні ознаки перелому: патологічна рухомість у незвичайному місці та крепітація кісткових уламків. На рентгенограмі лівого стегна у двох проєкціях виявлено уламковий перелом дистального метаепіфізу стегнової кістки зі зміщенням уламків. Ознак порушення кровопостачання та іннервації гомілки і стопи не виявлено. Який вид остеосинтезу показаний цьому пацієнтові відповідно до рекомендацій Асоціації остеосинтезу?

- A. Остеосинтез апаратом Ілізарова
- B. Остеосинтез титановими цвяхами
- C. Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез
- D. Остеосинтез стрижневим апаратом зовнішньої фіксації
- E. Малоінвазивний остеосинтез пластиною з кутовою стабільністю

3. З чим пов'язана безпосередня причина загрози життю пацієнта при травматичному шоці?

- A. З розладом мікроциркуляції в результаті метаболічного ацидозу
- B. З численними переломами плоских кісток
- C. З артеріальною кровотечею
- D. З венозною кровотечею
- E. З численними переломами довгих трубчатих кісток

4. У пацієнтки віком 54 роки, яка впродовж 10 років перебуває на обліку лікаря з приводу ревматоїдного артриту, під час лабораторних обстежень виявлено зміни показників аналізу крові. Які зміни лабораторних показників крові не властиві для хворих на ревматоїдний артрит?

- A. Показник гемоглобіну 35-40 г/л
- B. Висока ШОЕ

C. Гіперхромна анемія

D. Зниження кількості еритроцитів

E. Зниження кількості лейкоцитів

5. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на біль у ділянці лівого кульшового суглоба, який посилюється під час рухів. Хворіє декілька років, попередні травми заперечує. Під час обстеження спостерігається: обмеження активних рухів у суглобі, пасивні рухи різко болючі, гіпотрофія м'язів стегна. Визначається привідна контрактура цього суглоба. На рентгенограмі виявлено звуження суглобової щілини, наявність крайових остефітів, деформація голівки стегна, склероз субхондральних ділянок. Встановіть діагноз.

- A. Пухлина верхньої третини стегна
- B. Остеоартроз лівого кульшового суглоба
- C. Поперековий радикуліт
- D. Туберкульоз кульшового суглоба
- E. Ревматоїдний артрит

6. Лікар, оглядаючи пацієнтку віком 35 років з підозрою на перелом лівого передпліччя, виявив локальну болючість у середній третині передпліччя, набряк та крепітацію уламків. Передпліччя деформоване. Активні рухи в променево-зап'ястковому та ліктьовому суглобах обмежені через біль. Який із симптомів найхарактерніший для перелому?

- A. Крепітація уламків
- B. Набряк і деформація
- C. Відсутність рухів у суглобі
- D. Локальна болючість
- E. Гематома

7. Військовослужбовець віком 25 років отримав мінно-вибухове поранення правої стегнової кістки. Шпиталізований до стабілізаційного пункту в стані середньої тяжкості. Під час огляду виявлено: рвана рана на зовнішній поверхні стегна розміром 10x14 см, рана помірно кровоточить. У рані спостерігаються кісткові відламки. Яку медичну допомогу потрібно надати потерпілому?

- A. Промивання рани, апарат зовнішньої фіксації
- B. ПХО рани, апарат зовнішньої фіксації
- C. Фасціотомія, апарат зовнішньої фіксації
- D. ПХО рани, циркулярна гіпсова пов'язка
- E. ПХО рани, шина Крамера

8. Внаслідок падіння на лівий бік з висоти власного зросту жінка віком 78 років не

змогла самотійно піднятися. Під час шпиталізації виявлено: зовнішня ротація лівого стегна, вкорочення лівої кінцівки на 4 см, позитивний симптом прилиплої п'яти ліворуч. На рентгенограмі виявлено: субкапітальний перелом шийки стегнової кістки лівої кінцівки зі зміщенням уламків. Який вид лікування показаний у цьому разі відповідно до рекомендацій Асоціації остеосинтезу?

- A. Остеосинтез PFNA
- B. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба
- C. Остеосинтез канюльованими гвинтами
- D. Деротаційний чобіток
- E. Скелетне витягання

9. Що є найбільш ранньою рентгенологічною ознакою при деформуючому артрозі?

- A. Зниження висоти щілини суглоба
- B. Деформація суглобових поверхонь
- C. Деформація хряща
- D. Крайові кісткові розростання
- E. Кистоподібні просвітлення

10. Чоловік унаслідок ДТП отримав закритий перелом тазових кісток та лівої стегнової кістки. Під час шпиталізації в реанімаційне відділення пацієнту встановлено систему скелетного витягання. У якому періоді травматичної хвороби потрібно проводити оперативне лікування переломів?

- A. III
- B. I
- C. II
- D. -
- E. IV

11. Хлопчик віком 8 років протягом 4 міс скаржиться на біль різної інтенсивності у ділянці правого кульшового суглобу, кульгавість. Під час огляду активні рухи в суглобі обмежені, пасивні - болючі. На рентгенограмі у голівці стегнової кістки видно ділянку розміром 1–1,5 см з підвищеною щільністю і сплюсненням епіфіза. Суглобова щілина розширена, а суглобова впадина не змінена. Встановіть попередній діагноз.

- A. Деформуючий артроз
- B. Ревматоїдний артрит
- C. Туберкульозний артрит
- D. Хвороба Бехтерева

E. Асептичний некроз голівки стегнової кістки

12. Пацієнт віком 54 роки шпиталізований через 40 хв після дорожньо-транспортної пригоди. Діагностовано: односторонній перелом ребер, закритий перелом стегнової кістки, перелом кісток тазу. Співвідношення частоти пульсу до систолічного артеріального тиску становить 1,35. Визначте можливий рівень крововтрати.

- A. 1–1,5 л
- B. 0,5–1 л
- C. 2–2,5 л
- D. 2,5–3 л
- E. 1,5–2 л

13. До військово-польового шпиталю шпиталізовано військовослужбовця з діагнозом: вогнепальне сліпе поранення м'яких тканин с/3 правого стегна, закритий перелом с/3 обох кісток правої гомілки зі зміщенням фрагментів, травматичний шок I ст. На попередньому етапі евакуації пацієнтові виконана імобілізація переломів задньою гіпсовою шиною, хірургічна обробка рани правого стегна, інфузійна терапія розчинами кристалоїдів. На 2 добу больовий синдром у правій гомілці значно посилюється, пацієнт відзначає оніміння пальців правої стопи. Під час пальпації виявлено: напруженість м'яких тканин правої гомілки, послаблення пульсації на A) dorsalis pedis та A) tibialis posterior. Яке ускладнення розвинулося у пораненого?

- A. Гострий компартмент-синдром
- B. Мезентеріальний тромбоз
- C. Компресійно-ішемічна нейропатія великогомілкового нерва
- D. Хронічний компартмент-синдром
- E. Альгодистрофія Зудека

14. Укажіть правильну послідовність зон пошкодження, що формуються у рані вогнепального каналу?

- A. Зона тканинного детриту, травматичного некрозу, молекулярного струсу
- B. Зона молекулярного струсу, тканинного детриту, травматичного некрозу
- C. Зона тканинного детриту, молекулярного струсу, травматичного некрозу
- D. -

Е. Зона травматичного некрозу, тканинного детриту, молекулярного струсу

15. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на виражений біль у суглобах кистей, ранкову скутість рухів протягом 3 год. Хворіє 5 років. Об'єктивно спостерігається симетричне ураження суглобів кистей, їх деформація, підвивихи, атрофія міжкісткових м'язів. В аналізі крові виявлено: еритроцити - $3,8 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити - $10,2 \cdot 10^9/л$, ШОЕ - 48 мм/год, С-реактивний білок - 42 Од/мл, ревматоїдний фактор - 114 Од/мл. Який попередній діагноз?

- А. Псоріатичний артрит
- В. Подагричний артрит
- С. Системний червоний вовчак
- Д. Лайм-бореліоз
- Е. Ревматоїдний артрит

16. За рахунок яких суглобів зумовлена супінація стопи при вродженій клишоногості?

- А. Підтаранного і Шопара
- В. Гомілковостопного
- С. Гомілковостопного і суглоба Лісфранка
- Д. Шопара і Лісфранка
- Е. Гомілковостопного і підтаранного

17. Виберіть правильну послідовність стадій патогенезу асептичного некрозу голівки стегнової кістки.

- А. Порушення кровообігу, остеонекроз, контрактура суглоба, склероз, фіброз
- В. Остеонекроз, порушення кровообігу, фіброз, склероз, контрактура суглоба
- С. Остеонекроз, порушення кровообігу, склероз, фіброз, контрактура суглоба
- Д. -
- Е. Порушення кровообігу, остеонекроз, фіброз, склероз, контрактура суглоба

18. Пацієнтка віком 23 років скаржиться на біль у лівому колінному суглобі, збільшення суглобу в об'ємі, обмеження рухів, кульгання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 7 місяців. На рентгенограмах колінного суглоба в прямій проєкції у зовнішньому виростку великогомілкової кістки виявлено округлу тінь зниженої щільності. Як проявляється така зміна кісткової тканини на рентгенограмі?

- А. Деструкція
- В. Дефект

- С. Остеопороз
- Д. Гіперостоз
- Е. Періостит

19. У військово-медичний клінічний центр шпиталізований військовослужбовець віком 40 років із вогнепальним уламковим переломом середньої третини лівої стегнової кістки. Вогнепальне поранення отримав 2 міс тому. Під час огляду загальний стан пацієнта задовільний. Загальноклінічні аналізи в межах норми. На лівій кінцівці спостерігається апарат зовнішньої фіксації. На рентгенограмі стегна - багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням відламків. Рана на передній поверхні стегна 4х6 см, загоїлась вторинним натягом. Яка подальша тактика лікування?

- А. Подальше лікування АЗФ
- В. Демонтаж АЗФ, гіпсова лонгета
- С. Демонтаж АЗФ, заглиблений остеосинтез
- Д. Перемонтаж АЗФ
- Е. Демонтаж АЗФ, скелетне витягіння

20. Яка основа причина збільшення частки ускладнень при політравмі?

- А. Інтоксикація
- В. Знижений імунітет
- С. Зміщення відламків зламаних кісток
- Д. Масивна крововтрата
- Е. Авітаміноз

21. Намагаючись париувати удар палицею по голові, пацієнт підставив зігнуту в лікті ліву руку. Удар прийшовся на верхню третину передпліччя. Під час огляду в приймальному відділенні встановлено, що на рівні верхньої третини лівої ліктьової кістки є підшкірна гематома, патологічна рухливість, кісткова крепітація. Осьове навантаження передпліччя викликає біль у проєкції удару. Активне і пасивне згинання в ліктьовому суглобі відсутнє, спостерігається позитивний симптом пружного опору. Встановіть попередній діагноз.

- А. Перелом Колліса лівого передпліччя
- В. Перелом променевої кістки в типовому місці
- С. Переломовивих Монтеджі лівого передпліччя
- Д. Вивих кісток лівого передпліччя
- Е. Перелом обох кісток лівого передпліччя

22. Пацієнтка віком 38 років протягом року відзначає слабкість, пітливість,

субфебрильну температуру тіла, біль і обмеження рухів у лівому колінному суглобі. Об'єктивно спостерігається: положення лівої кінцівки вимушене, колінний суглоб збільшений в об'ємі, болючий під час пальпації, рухи обмежені. Проба Манту з 2 ТО - папула 25 мм. Який попередній діагноз?

- A. Посттравматичний артрит
- B. Остеоартрит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. **Туберкульозний гоніт**
- E. Пухлина колінного суглоба

23. Чоловік віком 25 років самостійно звернувся до лікаря зі скаргами на біль у правому над'ятково-гомільковому суглобі після травми, отриманої 10 днів тому. Під час обстеження шкіра не змінена, незначний набряк. Наявний біль під час пальпації зовнішньої та внутрішньої кісточки правої гомілки. Розладів чутливості не виявлено. Пульсація на магістральних артеріях збережена. Після рентгенологічного обстеження виявлено перелом малогомілкової кістки на рівні дистального міжгомількового синдесмозу та підвивих стопи назовні. Яке лікування є найдоцільнішим?

- A. Фіксація довгою гіпсовою лонгетою
- B. Фіксація короткою гіпсовою лонгетою
- C. Апарат зовнішньої фіксації
- D. **Відкрита репозиція та внутрішня фіксація**
- E. Закрите вправлення та зовнішня гіпсова фіксація

24. За 30 хв після звільнення з-під завалу військовослужбовець почав виявляти скарги на біль у лівій гомілці та стопі, порушення чутливості та опороспроможності лівої нижньої кінцівки. Шпиталізований до медичної роти. Об'єктивно спостерігається: ліва гомілка напружена, розлита підшкірна гематома, під час пальпації виявлено болючість м'яких тканин, патологічна рухомість і кісткова крепітація не визначаються. Пульсація артерій у ділянці лівої стопи послаблена, гіпостезія в ділянці пальців лівої стопи. Підфасціальний тиск дорівнює діастолічному. Якою повинна бути подальша тактика лікування?

- A. **Невідкладна фасціотомія**
- B. Динамічний нагляд
- C. Аспірація гематоми лівої гомілки

- D. Призначення діуретиків і динамічний нагляд
- E. Імобілізація кінцівки задньою гіпсовою шиною

25. Чоловік віком 40 років, скаржиться на біль у попереку. Під час огляду виявлено: поперековий лордоз збільшений, слабкість і парестезія нижніх кінцівок. На рентгенограмах відзначається зсув хребця L4 уперед на 75% тіла (спондилолістез). Який метод лікування є доцільним у цьому випадку?

- A. **Хірургічний**
- B. Фізіотерапевтичний
- C. Фіксація поперекового відділу хребта корсетом
- D. Протизапальне лікування нестероїдними препаратами
- E. Паравертебральне введення стероїдних протизапальних засобів

26. Пацієнт віком 58 років виписується зі стаціонару, де йому 6 днів тому виконали операцію ендопротезування кульшового суглоба з приводу диспластичного остеоартриту IV ступеня. Які рекомендації з реабілітації є недоречними?

- A. **Рання ходьба без милиць**
- B. Щоденні вправи пасивних рухів у суглобах кінцівок
- C. Повне навантаження через 2-2,5 міс після безцементного ендопротезування
- D. Повне навантаження через 1-1,5 міс після цементного ендопротезування
- E. Терапевтичні вправи під наглядом фізичного терапевта

27. Укажіть обсяг медичної допомоги в 'червоній зоні' у разі мінно-вибухової травми та ампутації стопи і над'яtkово-гомількового суглоба.

- A. Накладення асептичної пов'язки, внутрішньовенне введення сольових розчинів, попередження розвитку шоку та імобілізація кінцівки
- B. Накладення асептичної пов'язки, знеболення та імобілізація кінцівки
- C. **Накладення турнікету в порядку само- або взаємодопомоги**
- D. Накладення асептичної пов'язки, знеболення, антибіотикопрофілактика, імобілізація кінцівки транспортною шиною

Е. Детальний огляд ураженого сегмента та пораненого і надання максимального обсягу медичної допомоги

28. Укажіть основні патогенні фактори артрозу.

- А. Надмірна вага тіла
- В. Порушення гормонального балансу організму
- С. Порушення обміну речовин з надмірним накопиченням сечової кислоти в крові
- Д. Аліментарна недостатність хондроїтінсульфітів у харчовому раціоні
- Е. Нерівномірний характер розподілу напруження суглобових поверхонь з їхньою концентрацією на окремих ділянках

29. Військовослужбовець був шпиталізований на II рівень медичної евакуації із вогнепальним кульовим сліпим пораненням м'яких тканин правої гомілки. Під час огляду виявлено: на задній поверхні в ділянці с/з гомілки спостерігається вогнепальна рана розміром 4х3 см, краї рани осаджені, під час дотику інструментом не чутливі, рановий канал лінійний, заповнений кров'яними згустками та уривками м'яких тканин. Наявність якої зони вогнепальної рани хірург враховує під час висічення нежиттєспроможних тканин у такого пацієнта?

- А. Первинного ранового некрозу
- В. Ранового каналу
- С. Демаркації
- Д. Вторинного ранового некрозу
- Е. Відриву

30. До лікаря-травматолога звернулася мати дитини віком 2,5 місяці. Під час огляду під час поступового згинання і розведення ніг спостерігається обмеження руху в правому кульшовому суглобі. Визначається зовнішня ротація та вкорочення правої ноги, асиметрія сідничних та стегнових шкірних складок. Встановіть попередній діагноз.

- А. Вроджений вивих лівого стегна
- В. Асептичний некроз голівки стегнової кістки
- С. Підвивих стегна
- Д. Ушкодження кульшового суглоба під час пологів

Е. Дисплазія кульшового суглоба

31. Що є абсолютними показаннями для остеосинтезу апаратом зовнішньої фіксації?

- А. Закриті переломи зі зміщенням відламків на повний поперечник і більше
- В. Відкриті переломи, і відкриті та закриті уламкові переломи
- С. Перелом зі зміщенням на тлі остеопору
- Д. Перелом з пошкодженням магістральної судини
- Е. Подвійні переломи

32. У чому полягають особливості відновлення кісткової тканини при черезкістковому позаосередковому компресійно-дистракційному остеосинтезі?

- А. Створення умов для репаративної регенерації кісткової тканини
- В. Створення умов для формування ендостальної кісткових мозолів
- С. Створення щільної футлярної кісткової мозолі
- Д. Створення надмірної періостальної кісткової мозолі
- Е. Створення щільної ендостальної мозолі

33. Яка найчастіша причина смерті поранених на полі бою, яку можна попередити?

- А. Напружений пневмоторакс
- В. Проникні поранення грудної та черевної порожнини
- С. Порушення прохідності дихальних шляхів, поранення органів грудної та черевної порожнини
- Д. Інфекційні ускладнення, гангрена
- Е. Масивна кровотеча з кінцівки

34. Військовослужбовець віком 40 років отримав різану рану задньої ділянки лівого колінного суглоба. Виникла інтенсивна фонтануюча кровотеча яскраво-червоного кольору. Пальцевим притисненням стегнової артерії в паху кровотечу тимчасово зупинено, накладена пов'язка, яка миттєво просякла кров'ю, вирішено накласти на стегно турнікет та транспортувати до хірургічного відділення. На який максимальний термін допустиме накладання джгута?

- А. До зупинки кровотечі

- B. 1 год
- C. 30 хв
- D. 2 год
- E. 8 год

35. На чому базується міжнародна класифікація остеоартриту за Kellgren-Lawrence, що включає 5 стадій ураження при остеоартриті?

- A. Комп'ютерній томографії
- B. Ультрасонографії
- C. Магнітно-резонансній томографії
- D. Сцинтиграфії
- E. Рентгенологічному обстеженні

36. Військовослужбовець віком 45 років отримав мінно-вибухову травму, пошкодження органів черевної порожнини. Як повинно бути проведено 'повне відключення' прямої кишки при вогнепальних пораненнях її позаочеревинного відділу?

- A. Сигмостома
- B. Дводульна сигмостома або операція Гартмана
- C. Діагностична лапароскопія
- D. -
- E. Колостома

37. Укажіть правильну послідовність періодів перебігу травматичної хвороби.

- A. Догоспітальний період, реанімаційний період, період інтенсивної терапії, період спеціалізованого лікування
- B. -
- C. Період шоку, період нестійкої адаптації, період розвитку ускладнень, період повної стабілізації життєво важливих функцій
- D. Реанімаційний період, період адаптації, період розвитку ускладнень, період стабілізації життєво важливих функцій
- E. Гострий період, період нестійкої адаптації, період максимальної можливості розвитку ускладнень, період повної стабілізації життєво важливих функцій

38. Що являє собою поняття травматична хвороба?

- A. -
- B. Комплекс патологічних реакцій організму у відповідь на пошкодження та подальший розвиток травматичного процесу при політравмі

C. Травматичне пошкодження в межах одного анатомо-функціонального утворення або в декількох місцях цього утворення

D. Тяжкий стан постраждалого, який супроводжується порушенням життєво важливих функцій у вигляді травматичного шоку

E. Одночасна травма органів опори та руху та магістральних судин і нервів

39. Укажіть достовірну клінічну ознаку вродженого вивиху стегна у дитини віком до 3-х міс.

- A. Асиметрія кількості сідничних складок
- B. Вкорочення нижньої кінцівки
- C. Симптом Маркса-Ортолані
- D. Обмеження внутрішньої ротації
- E. Обмеження відведення стегна

40. Використання хірургічної концепції 'Damage control surgery' показано пораненим із важкими та вкрай важкими травмами. Що є основним лейтмотивом цієї хірургічної тактики лікування?

- A. Основні хірургічні операції виконуються одноетапно
- B. Розподіл хірургічного лікування на етапи для збереження життя пораненого шляхом скорочення обсягу, терміну виконання і травматичності першої операції з остаточним відновленням органів та структур після стабілізації систем життєзабезпечення
- C. Усунення життєзагрозливих станів із максимальною діагностикою всіх органів та систем і їх одномоментне лікування в III періоді травматичної хвороби
- D. Розподіл хірургічних втручань за пріоритетом із одноетапним хірургічним лікуванням в I періоді травматичної хвороби
- E. Хірургічні втручання виконуються одноетапно в III періоді травматичної хвороби

41. В якому разі показане інтраартикулярне введення глюкокортикостероїдів під час лікування пацієнтів з остеоартритом?

- A. Як перший крок при лікуванні запалення та болю в комбінації з нестероїдними протизапальними препаратами

В. В якості другої лінії терапії за неефективності нестероїдних протизапальних препаратів

С. При остеоартрозі 3-4 стадії як перший крок у лікуванні

Д. У разі, коли пацієнт з остеоартрозом має індекс маси тіла 32-34

Е. Для усунення вираженого больового синдрому в суглобі

42. Що є джерелом болю під час артрозу суглоба?

А. Механічне подразнення больових рецепторів, що розташовані в капсулі суглоба та синовіальній оболонці

В. Збільшення сили тертя між суглобовими поверхнями внаслідок недостатньої кількості синовіальної рідини

С. Збільшення тиску синовіальної рідини

Д. Руйнований хрящ суглоба з утворенням дефектів

Е. Механічне подразнення хрящової поверхні суглоба

43. До відділення політравми бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги шпиталізовано водія авто після ДТП із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, закритою травмою живота, відкритим переломом кісток лівої гомілки, нестабільною гемодинамікою, ШКГ - 8 балів, запахом алкоголю з ротової порожнини. Пацієнт транспортований в операційну, розпочато заходи реанімації. Рентгенографію яких локалізацій потрібно виконати першочергово?

А. Ліва гомілка, грудна клітка

В. Таз, ліва гомілка

С. Голова, таз

Д. Голова, ліва гомілка

Е. Грудна клітка, таз

44. Що належить до дистракційного елементу конструкції транспортної шини Дітеріхса?

А. Дерев'яна підшва

В. Коротка дошка-шина

С. Закрутка

Д. Дерев'яна підшва з закруткою

Е. Довга дошка-шина

45. Чоловіка віком 75 років шпиталізовано до відділення екстреної медичної допомоги зі скаргами на виражений біль у правому

стегні, деформацію стегна, порушення опороспроможності правої нижньої кінцівки. З анамнезу відомо: травма відбулась 4 год тому, коли чоловік упав із даху свого дому. Об'єктивно спостерігається: блідий, на поставлені запитання відповідає мляво, АТ - 95/60 мм рт. ст., ЧСС - 100/хв. Визначається вкорочення правої нижньої кінцівки на 3 см, під час пальпації спостерігається біль, патологічна рухомість та кісткова крепітація в ділянці с/3 правого стегна. Встановіть попередній діагноз.

А. Закритий перелом с/3 правої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів. Травматичний шок І ст.

В. Закритий перелом с/3 правої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів. Травматичний шок ІІ ст.

С. Закритий перелом в/3 правої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів. Травматичний шок ІІ ст.

Д. Закритий перелом в/3 правої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів. Травматичний шок І ст.

Е. Закритий перелом с/3 правої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів. Травматичний шок ІІІ ст.

46. До відділення політравми шпиталізовано пацієнта з діагнозом: закрыта черепно-мозкова травма: струс головного мозку (AIS=1 бал). Закрита травма грудної клітки: множинні фрагментарні переломи ребер зліва, лівобічний гемопневмоторакс, флотуюча грудна клітка зліва (AIS=4 бали). Закрита травма живота: розрив селезінки (AIS=3 бали). Закритий перелом с/3 лівої стегнової кістки (AIS=3 бали). Закритий перелом с/3 правої плечової кістки (AIS=2 бали). Розрахуйте тяжкість травми пацієнта за ISS.

А. 13 балів

В. 10 балів

С. 39 балів

Д. 35 балів

Е. 34 бали

47. Чоловік віком 56 років отримав травму під час ДТП. Після надання першої медичної допомоги шпиталізований до лікарні. Загальний стан пацієнта середньої важкості. ЧСС - 100/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Під час об'єктивного обстеження діагностовано відкриті переломи с/3 правої та лівої стегнових кісток, закритий перелом діафізу правої гомілки. Яку лікувальну

тактику потрібно застосувати для цього пацієнта?

- A. Інтрамедулярний остеосинтез
- B. Накладання гіпсових пов'язок
- C. Накістковий остеосинтез
- D. Скелетне витягання
- E. Остеосинтез переломів апаратом зовнішньої фіксації

48. Пацієнт віком 41 рік отримав травму 3 тижні тому. Діагноз: політравма, закрита ЧМТ, струс головного мозку, закритий багатоуламковий перелом проксимального метаепіфізу лівої великогомілкової кістки АО 41-C2. Наразі пацієнту змонтовано апарат зовнішньої фіксації (АЗФ). Яка оптимальна тактика хірургічного лікування перелому великогомілкової кістки?

- A. Остеосинтез LCP-пластиною медіальної колони великогомілкової кістки з кістковою пластиною
- B. Остеосинтез LCP-пластиною медіальної колони великогомілкової кістки і звичайною пластиною латеральної колони
- C. Остеосинтез DHS-системою з кістковою пластиною
- D. Остеосинтез LC-DCP-пластиною медіальної колони великогомілкової кістки і звичайною пластиною латеральної колони
- E. Продовжувати лікування в АЗФ

49. До приймального відділення шпиталізовано пацієнта з політравмою, діагностовано: кома III, перелом стегна, клініка травматичного шоку. Якому періоду травматичної хвороби відповідає стан постраждалого?

- A. Період повної стабілізації життєво важливих функцій
- B. -
- C. Період нестійкої адаптації
- D. Період максимальної можливості розвитку ускладнень
- E. Гострий період

50. Який захід не включає тактика хірурга під час відкритих переломів обох стегнових кісток та стані травматичного шоку II ступеня?

- A. Накладання апаратів зовнішньої фіксації
- B. Профілактику гнійних ускладнень

- C. Ранній стабільний інтрамедулярний остеосинтез одразу обох стегон
- D. Первинну хірургічну обробку ран
- E. Боротьбу з шоком і зупинку кровотечі

51. Що таке первинний снаряд, що завдає ураження при мінно-вибуховому пошкодженні?

- A. Снаряд від дії вибухового пристрою
- B. Снаряд, який виник в наслідок дії вибухового пристрою
- C. Снаряд, який виник під впливом дії вибухової хвилі
- D. Снаряд, який виник з елементів конструкції вибухового пристрою
- E. -

52. У яких випадках група інвалідності встановлюється 'безстроково'?

- A. Для осіб з неправильно зрощеним переломом стегнової кістки, що призводить до значного обмеження рухливості кінцівки
- B. Для осіб з хронічними захворюваннями, які не піддаються лікуванню та прогресують, ведучи до стійкої втрати працездатності
- C. Для осіб з неоартрозом плечової або стегнової кісток, який викликає сильний біль, обмежує рухливість і вимагає повторного хірургічного втручання
- D. Для осіб з відкритими переломами обох стегнових кісток, що потребують тривалої реабілітації, мають збільшений ризик розвитку ускладнень та вимагають постійної допомоги або спеціалізованих засобів для пересування
- E. Для осіб з анатомічними дефектами, необоротними порушеннями функцій, включно з ампутацією кінцівок, та осіб, що досягли пенсійного віку

53. Військовослужбовець віком 45 років наступив на невідомий вибуховий предмет, після чого був шпиталізований на II рівень медичної евакуації. Під час огляду спостерігається неповний відрив лівої нижньої кінцівки на рівні 1/3 гомілки, стопа бліда, пульсація на артеріях стопи відсутня. Під час ревізії рани виявлено ознаки травматичної ішемії великогомілкової артерії. Якого обсягу медичної допомоги потребує пацієнт на цьому рівні медичної евакуації?

- A. ПХО, МОС перелому великогомілкової кістки АЗФ на стрижневій основі
- B. ПХО, іммобілізація перелому великогомілкової кістки задньою гіпсовою шиною
- C. Туалет рани ведеться відкритим методом
- D. ПХО, первинна ампутація на рівні відриву
- E. ПХО, первинна ампутація в межах життєспроможних тканин

54. За даними клініко-інструментальних обстежень пацієнту з кататравмою, встановлено попередній діагноз: поєднана травма. Закрита черепно-мозкова травма: струс головного мозку (клінічно). Закрита травма грудної клітки: переломи IV, V, VI, VII ребер справа; великий правобічний пневмоторакс (за даними рентгенографії). Закрита травма живота (FAST позитивний). Відкритий перелом II ст. н/3 правої стегнової кістки. Закритий перелом в/3 лівої великогомілкової кістки. Якій з травмованих анатомічних ділянок потрібно надати пріоритет при виконанні оперативних втручань та маніпуляцій?

- A. Праве стегно
- B. Ліва гомілка
- C. Голова
- D. Живіт
- E. Грудна клітка

55. Військовослужбовець отримав вогнепальне кульове поранення правої половини грудної клітки та лівої нижньої кінцівки. Побратимами був наданий базовий рівень медичної допомоги, евакуйований до медичного пункту батальйону. Яка допомога буде надана постраждалому на цьому етапі евакуації?

- A. Спеціалізована медична
- B. Кваліфікована медична
- C. Перша медична
- D. Перша лікарська
- E. Реабілітаційна

56. У дівчини віком 15 років під час обстеження виявлено викривлення грудного відділу хребта у фронтальній площині, яке чітко виявляється у пацієнтки стоячи, однак під час нахилу тулуба вперед це викривлення зникає. На рентгенограмі стоячи кут викривлення грудного відділу хребта за Коббом становить 25°, лежачи кут викривлення відсутній. Встановіть діагноз.

- A. Сколіоз грудного відділу хребта I ступеня
- B. Сколіотична постава
- C. Кіфосколіоз грудного відділу хребта
- D. Остеохондропатія тіла хребця (хвороба Кальве)
- E. Юнацький кіфоз грудного відділу хребта I ступеня

57. Укажіть характерну рентгенологічну картину для туберкульозного спондиліту.

- A. Наявність зміщення суміжних хребців за шириною
- B. Клиноподібна деформація тіла хребця
- C. Крайова деструкція замикаючих пластинок суміжних хребців і міжхребцевого диску
- D. Деструкція суглобових відростків
- E. Деструкція центральної частини хребця

58. Під час огляду пораненого на сортувальному майданчику медичної роти, евакуйованого машиною з поля бою, встановлено: кульове поранення отримав 6-7 год тому, праве плече деформоване, значно вкорочене. Пов'язка в його середній третині помірно просякла кров'ю. Після зняття пов'язки на задній латеральній поверхні плеча - вхідний отвір, а на передній медіальній поверхні - вихідний отвір ранового каналу. Права кисть зависла, активне розгинання кисті і основних фаланг відсутнє. Під час надання першої медичної допомоги стрільцем-санітаром іммобілізація не була виконана. Які неврологічні структури уражені?

- A. Пошкодження ліктьового нерва
- B. Пошкодження серединного нерва
- C. Пошкодження променевого нерва
- D. Пошкодження верхнього стовбура плечового сплетіння
- E. Пошкодження нижнього стовбура плечового сплетіння

59. У пацієнтки віком 53 роки діагностовано ревматоїдний артрит з ураженням колінних та ліктьових суглобів, суглобів кистей і стоп - II стадія (продуктивно-деструктивний панартрит), ексудативно-проліферативна фаза. Яка ортопедична корекція рекомендована для лікування цієї пацієнтки?

- A. Тотальна синовіокапсулектомія, редресація, видалення панусу
- B. Артроліз, хейлектомія
- C. Атродез

- D. Видалення остеофітів, менісків, хряща
- E. Артропластика, ендопротезування

60. Як називається хірургічне втручання, метою якого є видалення сторонніх тіл, нежиттєздатних тканин, створення сприятливих умов для загоєння рани та попередження ранової інфекції?

- A. Первинна хірургічна обробка рани
- B. Обробка вогнепальної рани
- C. Відстрочена хірургічна обробка рани
- D. Вторинна хірургічна обробка рани
- E. Хірургічна обробка рани

61. Військовослужбовець отримав вогнепальний перелом середньої третини кісток гомілки. Що потрібно іммобілізувати з метою транспортної іммобілізації?

- A. Використати шину Крамера
- B. Іммобілізація не потрібна, лише накладення турнікету або тиснучої пов'язки з закриттям рани стерильною пов'язкою
- C. Іммобілізуємо лише поранений сегмент
- D. Іммобілізація гомілково-ступневого суглоба та ушкодженого сегмента
- E. Іммобілізація ураженого сегмента та двох суміжних суглобів

62. У пацієнтки віком 54 роки виявлено закритий перелом кісток гомілки зі зміщенням уламків: перелом внутрішньої кістки на рівні суглобової щілини, перелом зовнішньої кістки на рівні синдесмозу, розрив синдесмозу та підв'язки стопи назовні. Який вид лікування найдоцільніше застосувати у цьому разі?

- A. Відкрита репозиція, накістковий остеосинтез
- B. Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим
- C. Закрита репозиція, гіпсова іммобілізація
- D. Відкрита репозиція, інтрамедулярний остеосинтез
- E. Скелетне витягання

63. Потерпілий отримав травму в результаті ДТП. Скаржиться на біль в ділянці тазу, найменші рухи ногами посилюють біль. Стан середньої тяжкості. Шкірні покриви бліді. АТ - 100/60 мм рт. ст., ЧСС - 110/хв, задовільного наповнення. Деформація тазового кільця. Симптом прилиплої п'яти позитивний. З чим пов'язаний розвиток шоку у цього постраждалого?

- A. З ушкодженням органів черевної порожнини
- B. З порушенням кровообігу в нижніх кінцівках
- C. З порушенням цілісності тазового кільця
- D. З ушкодженням кістковими відламками 'кінського хвоста'
- E. З масивною крововтратою із ушкодженої кісткової тканини й аферентною больовою і не больовою імпульсацією

64. Що розуміється під стабільністю конструкції 'уламки-фіксатор'?

- A. Здатність зберігати стан рівноваги протягом часу
- B. Властивість зберігати вихідну форму впродовж певного терміну
- C. Відсутність переміщень відламків
- D. Наявність незначних деформацій фіксатора без його руйнування
- E. Відсутність руйнування фіксатора

65. У дитини віком 14 років на основі клінічного, рентгенологічного, КТ обстежень встановлено діагноз: хвороба Блаунта лівої гомілки, варусна деформація лівого колінного суглоба. Якою буде подальша лікувальна тактика?

- A. Консервативне лікування, обмеження навантаження, ЛФК, масаж, фізіотерапія
- B. Аутопластика медіальної зони проксимального паросткового хряща, фіксація великогомілкової кістки пластиною
- C. Артродез лівого колінного суглоба з вирівнюванням осі кінцівки
- D. Корируюча остеотомія лівої великогомілкової кістки з фіксацією пластиною
- E. Обмеження навантаження, кальцій, полівітаміни, раціональна дієта, носіння наколінника

66. Військовослужбовець отримав вогнепальний перелом кісток гомілки. Якою буде тактика менеджменту рани з метою транспортної іммобілізації?

- A. Накласти подвійний еластичний бинт
- B. Виконати іммобілізацію шиною Дітерікса
- C. Зафіксувати гомілку фанерною шиною

D. Рану закрити асептичною пов'язкою та накласти шину Крамера від рівня дистальної третини стегна з фіксацією стопи

E. Зафіксувати гомілку і стопу драбинчастою шиною

67. Чоловік віком 35 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на біль та набряк правого коліна протягом останніх трьох днів. Пацієнт може пересуватися, але під час ходи біль у коліні посилюється. Під час огляду виявлено: температура тіла - 39,3°C, праве коліно гіперемоване, тепле на дотик та болюче, напружений синовіт. Під час пальпації позитивний симптом балотування надколінка. Яке з нижченаведених діагностичних досліджень колінного суглоба є найдоцільнішим?

- A. Артроскопія
- B. Артроцентез**
- C. Рентгенограма
- D. КТ
- E. МРТ

68. Пацієнт віком 45 років шпиталізований до лікарні. Під час обстеження йому встановлено діагноз: черепно-мозкова травма, забій головного мозку, відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням уламків. Який вид травми у пацієнта?

- A. Множинна
- B. Комбінована
- C. Монофокальна
- D. Поліфокальна
- E. Посідана**

69. До лікарні шпиталізовано пацієнта віком 30 років зі сполученою травмою. Після клінічного обстеження виявлено: розрив сечового міхура, забій головного мозку, нестабільний перелом кісток таза із порушенням переднього та заднього півкілець. Зазначте найдоцільніший на цьому етапі метод лікувальної іммобілізації кісток тазу.

- A. Гіпсова іммобілізація
- B. Гамак
- C. Внутрішній металоостеосинтез
- D. Накладання апарата зовнішньої фіксації**
- E. Скелетне витягання

70. Внаслідок ДТП пацієнт отримав удар по середній третині лівої гомілки, де утворилася рана 2х6 см, в якій видно уламки великогомілкової кістки та спостерігається помірна кровотеча. Клінічно визначаються достовірні ознаки

перелому: патологічна рухомість у незвичайному місці і крепітація кісткових уламків. На рентгенограмі лівого стегна у двох проєкціях виявлено поперечний перелом діяфізу стегнової кістки зі зміщенням уламків. Ознак порушення кровопостачання та іннервації гомілки і стопи не знайдено. Який вид остеосинтезу показаний цьому пацієнтові відповідно до рекомендацій Асоціації остеосинтезу?

- A. Закритий блокуючий інтрамедулярний остеосинтез**
- B. Остеосинтез стрижневим апаратом зовнішньої фіксації
- C. Остеосинтез пластиною з кутовою стабільністю
- D. Остеосинтез титановими цвяхами
- E. Остеосинтез апаратом Ілізарова

71. Що є рентгенологічними симптомами вродженого вивиху стегна у дітей, згідно зі схемою Хільгенрейнера?

- A. Ацетабулярний індекс - 27°, відстань - 10 мм, висота - 10 мм
- B. -
- C. Ацетабулярний індекс - 30°, відстань - 10 мм, висота - 12 мм
- D. Ацетабулярний індекс - 27°, відстань - 15 мм, висота - 12 мм
- E. Ацетабулярний індекс - 30°, відстань - 15 мм, висота - 7 мм**

72. У пацієнта віком 24 роки під час артроскопії колінного суглоба виявлене трансхондральне ушкодження меніска. Яка подальша лікувальна тактика?

- A. Видалити задній ріг до місця розриву
- B. Видалити передній ріг до місця розриву
- C. Видалити весь меніск
- D. Лаваж колінного суглоба
- E. Виконати зшивання меніска**

73. Пацієнтка віком 48 років звернулася до лікаря-ортопеда зі скаргами на ранкову скутість та біль у симетричних суглобах, що посилюються під час рухів, зокрема, у другій половині доби. Лікар запідозрив ранній ревматоїдний артрит. Які ознаки не належать до клінічних, властивих для раннього ревматоїдного артрити?

- A. Вранішня скутість більше 30 хв
- B. Позитивний тест 'стискання'
- C. Симетричні синовіти**
- D. Симетричне ураження суглобів кистей і стоп
- E. Уражено три і більше суглобів

74. До лікаря-ортопеда звернувся пацієнт віком 14 років зі скаргами на викривлення хребта. На рентгенограмі в прямій проекції виявлено сколіотичне викривлення в груднопоперековому відділі з кутом деформації за Cobb 36°. Над крилами клубових кісток спостерігаються півмісяцеві тіні зон окостеніння до половини окружності - симптом Ріссера. Про що свідчить цей симптом?

- A. Остеомієліт клубових кісток
- B. Подальше прогресування сколіозу
- C. Зупинку прогресування сколіозу
- D. Відсутність повного окостеніння клубових кісток
- E. Регресування сколіозу

75. Пацієнтка віком 83 роки з варусним субкапітальним переломом шийки стегнової кістки отримала травму 2 доби тому під час щоденної прогулянки у дворі власного будинку. З анамнезу відомо, що пацієнтка 10 років хворіє на остеоартрит обох кульшових суглобів та 3 роки тому перенесла інфаркт міокарда, неодноразово проходить курси стаціонарного консервативного лікування. Виберіть метод лікування пацієнтки.

- A. Тотальне ендопротезування ушкодженого кульшового суглоба у найближчий термін
- B. Однополюсне ендопротезування ушкодженого кульшового суглоба у найближчий термін
- C. Стабільно-функціональний металоостеосинтез інтрамедулярним стрижнем PFNA у найближчий термін
- D. Деротаційний чобіток протягом 30 діб з наступною вертикалізацією пацієнта та реабілітацією
- E. Скелетне витягання за надвиростки стегнової кістки протягом 30 діб з наступною вертикалізацією пацієнта та реабілітацією

76. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на біль у колінних, променевозап'ясткових суглобах, дрібних суглобах кистей. Хворіє 2 роки. Об'єктивно спостерігається: потовщення та болючість міжфалангових суглобів, під час згинання - хрускіт і болючість у колінних суглобах. У загальному аналізі крові: лейкоцити - $9,2 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 52 мм/год. На рентгенограмі кистей спостерігається звуження суглобової щілини, узури, остеопороз. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ревматоїдний артрит
- B. Деформуючий остеоартроз
- C. Реактивний артрит
- D. Ревматичний поліартрит
- E. Подагрична артропатія

77. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на біль у правій гомілці, періодичне підвищення температури тіла до 38-39°C. З анамнезу відомо, що 12 міс тому переніс відкритий перелом, проводилося лікування скелетним витяганням і гіпсовою пов'язкою. Наразі пересувається за допомогою милиць, самостійно пересуватися не може через біль. На передній поверхні правої гомілки є нориця з незначними гнійними виділеннями. Об'єктивно спостерігається: гомілка набрякла, навколо нориці наявна помірна гіперемія тканин. На рентгенограмі гомілки наявні хибний суглоб, кінцевий остеоліз уламків великогомілкової кістки, потовщення і вйчастість періосту. Встановіть діагноз.

- A. Перелом кісток гомілки
- B. Туберкульоз кісток гомілки
- C. Флегмона гомілки
- D. Посттравматичний остеомієліт
- E. Гематогенний остеомієліт

78. Які є види хірургічних втручань з приводу доброякісних пухлин кісток?

- A. Внутрішньокісткова резекція, крайова резекція кістки, клиноподібна резекція пласкої кістки, пластика дефекту кістки
- B. Внутрішній остеосинтез, зовнішній остеосинтез, репозиційний остеосинтез, ендопротезування суглоба
- C. Рентгенхірургічні втручання, термоабляція, пункційна вертебропластика, кріодеструкція пухлини
- D. Кріотерапія з використанням рідкого азоту для заморожування пухлини
- E. Резекція відділу (сегменту) кістки з пухлиною, ендопротезування суглоба, ектомія та екстирпація, ампутація, екзартикуляція кінцівки

79. Потерпілий віком 68 років був збитий легковим автомобілем 40 хв тому. Була короткочасна втрата свідомості, скарги на біль в грудній клітці, утруднене дихання, неможливість стати на ноги. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, адинамічний, горизонтальний ністагм. ЧДР - 32/хв. Під час пальпації грудної клітки

крепітація VI-VIII ребер праворуч по середньоключичній лінії АТ - 100/60 мм рт. ст. ЧСС - 120/хв, деформація обох гомілок в середній третині. Який вид політравми у пацієнта?

- А. Дорожньо-транспортна травма
- В. Побутова травма
- С. Поліфокальна травма опорно-рухового апарата
- Д. Множинна травма
- Е. Комбінована травма

80. Чоловік віком 57 років був збитий електропотягом. Шпиталізований до відділення політравми із діагнозом: поєднана черепно-мозкова, торакальна, абдомінальна, скелетна травма, відкрита черепно-мозкова травма, інтракраніальна гематома, відкритий двобічний гемопневмомедіастинум, травматичний розрив печінки, селезінки. Закриті багатоуламкові переломи н/3 обох стегнових кісток зі зміщенням фрагментів. Бригадою політравми проведено підрахунок балів ISS - 46 балів. Якому ступеню травми відповідає цей результат?

- А. Вкрай тяжкому
- В. Середньому
- С. Вкрай легкому
- Д. Важкому
- Е. Легкому

81. Про що свідчить симптом Тренделенбурга?

- А. Нестабільність у кульшовому суглобі
- В. Наявність хвороби Пертеса
- С. Функціональну недостатність пельвіо-трохантерних м'язів
- Д. Збільшення шийково-діафізарного кута більше норми (більше 130°)
- Е. Підвигих стегна

82. Пацієнт віком 25 років шпиталізований до травматологічного відділення після ДТП з діагнозом: закритий незрощений перелом діафізу лівої плечової кістки в н/3, ЧМТ, забій головного мозку. Травма відбулась 3 міс тому. Під час об'єктивного обстеження відзначається патологічна рухомість в н/3 лівого плеча. На рентгенограмі ознаки незрощеного перелома. Яку лікувальну тактику потрібно застосувати для цього пацієнта?

- А. Кісткова пластина, гіпсова пов'язка
- В. Апарат зовнішньої фіксації
- С. Накістковий остеосинтез

Д. Кісткова пластина, інтрамедулярний остеосинтез

Е. Кісткова пластина, накістковий остеосинтез

83. Пацієнтка віком 20 років шпиталізована з місця ДТП, права нижня кінцівка іммобілізована шинами Крамера. Свідомість сплутана, шкірні покриви бліді з ціанотичним відтінком. Пульс - 120/хв, АТ - 70/50 мм рт. ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерігається гіпорексія, гіпотонія м'язів. Який патологічний стан розвинувся у цієї пацієнтки?

- А. Кома помірна
- В. Травматичний шок III ст.
- С. Травматичний шок I ст.
- Д. Кома термінальна
- Е. Травматичний шок II ст.

84. Виберіть покази до хірургічного лікування асептичного некрозу голівки стегнової кістки.

- А. Обмеження амплітуди рухів у кульшовому суглобі
- В. -
- С. Біль у суглобі, пересування за допомогою милиць, згинально-розгинальна контрактура в суглобі
- Д. Інтенсивний біль, що з'являється при навантаженні
- Е. Порушення функції статика та ходьби II ст.

85. Укажіть, що належить до компонентів 'тріади смерті' у пацієнтів з політравмою.

- А. Алкалоз, гіпертермія, коагулопатія
- В. Гіпотензія, ацидоз, гіпотермія
- С. Гіповолемія, алкалоз, коагулопатія
- Д. Ацидоз, гіпотермія, коагулопатія
- Е. Анемія, ацидоз, гіповолемія

86. Для визначення осі нижньої кінцівки у положенні пацієнта лежачи лікар розташував вимірювальну стрічку по передній поверхні кінцівки. Які анатомічні орієнтири свідчитимуть про фізіологічність осі кінцівки?

- А. -
- В. Передньо-верхня ость здухвинної кістки, середина надколінка та перший міжпальцевий проміжок стопи
- С. Великий вертлюг, наколінник та зовнішня кісточка
- Д. Гребінь здухвинної кістки, зовнішній край надколінка, внутрішня кісточка

Е. Великий вертлюг, щілина колінного суглоба та зовнішня кісточка

87. Що є основним методом лікування вродженої дисплазії кульшових суглобів у дітей віком 1-6 міс?

- А. Поступове відведення стегон на системі клейового витягування
- В. Масаж та пасивне відведення стегон
- С. Поступове відведення стегон етапними гіпсовими пов'язками
- Д. Масаж в комплексі з остеотропною терапією
- Е. Широке сповивання з фіксацією стегон у відведенні та згинанні

88. До приймального відділення шпиталізовано потерпілого з місця дорожньо-транспортної пригоди без свідомості. АТ - 60/0 мм рт. ст., пульс - 120/хв. Після обстеження визначено закритий перелом середньої третини правої стегнової кістки, внутрішньочеревну кровотечу. На КТ мозку виявлено геморагічний забій лобної долі. В який термін необхідно виконати остеосинтез стегна апаратом зовнішньої фіксації?

- А. Після стабілізації гемодинаміки
- В. Після зупинки внутрішньочеревної кровотечі
- С. Відразу після надходження у лікарню
- Д. Після зупинки зовнішньої кровотечі
- Е. Безпосередньо після закінчення діагностичного процесу

89. У пацієнтки, шпиталізованої до лікарні після падіння з висоти 4 м, виявлено рани в ділянці с/3 обох гомілок розмірам 5х6 см, які рясно кровоточать. Осі гомілок викривлені. У ділянці ран визначається патологічна рухомість, кісткова крепітація. Пульс - 120/хв, ритмічний, слабого наповнення, АТ - 80/60 мм рт. ст. Встановіть попередній діагноз.

- А. Відкриті переломи в/3 кісток обох гомілок. Травматичний шок III ст.
- В. Відкриті переломи с/3 кісток обох гомілок. Травматичний шок I ст.
- С. Відкриті переломи с/3 кісток обох гомілок. Травматичний шок III ст.
- Д. Відкриті переломи в/3 кісток обох гомілок. Травматичний шок II ст.
- Е. Відкриті переломи с/3 кісток обох гомілок. Травматичний шок II ст.

90. Що є особливістю регенерації кістки за умов абсолютної стабільності уламків під час лікування переломів?

- А. Формування кісткового регенерата ендостально
- В. Формування сполучнотканинного регенерата
- С. Формування кістково-хрящового регенерата
- Д. Формування кісткового регенерата періостально
- Е. Формування кісткового регенерата інтрамедіарно

91. Військовослужбовець отримав удар трубою в ділянку передпліччя. Скаржиться на значний постійний біль, який не стихає після знеболення наркотичними анальгетиками. Спостерігається суттєвий набряк тканин, активні рухи пальців кисті не можливі, пасивні рухи супроводжуються нестерпним болем. Пульс на променевій артерії зберігається. Який попередній діагноз?

- А. Тромбоз плечової артерії
- В. Тракційне ураження плечового сплетення
- С. Ушкодження плечової артерії
- Д. Компартмент-синдром
- Е. Вивих кісток передпліччя

92. Укажіть характерні ознаки для посттравматичного хронічного остеомієліту.

- А. Рентгенологічні ознаки деструкції кістки, біль, що виникає при навантаженні
- В. Наявність відкритого перелому, який супроводжувався гнійно-некротичним ускладненням
- С. Стан після зануреного остеосинтезу відламків з наявністю нориць з гнійним виділенням
- Д. Гіперемія сегмента або його ділянки, періостальна реакція на рентгенограмі, підвищення температури
- Е. Наявність секвестру, інфікованого осередка в кістці, нориці з гнійним виділенням

93. Які вимоги до репозиції уламків під час лікування діафізарних переломів (простих та багатоуламкових)?

- А. Усунення зміщення по ширині з можливістю незначних залишкових

- кутових деформацій, які відповідають фізіологічним викривленням
- В. Відновлення осі, довжини, ротаційних відносин в ушкодженному сегменті**
 - С. Повне відновлення довжини та осі ушкодженого сегмента**
 - Д. Усунення зміщення по ширині з можливістю залишкових кутових деформацій до 3-5° у будь-якій площині**
 - Е. Анатомічна репозиція всіх уламків перелому**

94. Під час надання першої медичної допомоги пораненому віком 40 років, який отримав мінно-вибухову травму, військовим парамедиком виявлено: травматична ампутація правої гомілки на рівні с/3, інтенсивна пульсуюча кровотеча, кров яскраво-червоного кольору. Який обсяг першої медичної допомоги потрібно надати пораненому?

- А. Накладання джгута на рівні середньої третини стегна, асептична пов'язка, знеболювання**
- В. Стискаюча асептична пов'язка, накладання джгута на рівні верхньої третини гомілки, знеболювання**
- С. Максимальне згинання кінцівки в колінному суглобі, стискаюча пов'язка, знеболювання**
- Д. Пальцеве притиснення магістральної артерії, стискаюча пов'язка, знеболювання**
- Е. Стискаюча асептична пов'язка, знеболювання**

95. Чоловік віком 45 років у стані алкогольного сп'яніння впав з висоти 3-х метрів на випрямлені руки. Під час огляду спостерігається: блідий, визначаються рани на тильній поверхні у в/3 обох передпліч, дно рани заповнюють кісткові фрагменти. АТ - 90/60 мм рт. ст., пульс - 120/хв, ЧД - 22/хв. Рентгенологічно виявлено: багатоуламкові переломи обох кісток передпліч у в/3 зі зміщенням фрагментів. Лівобічний гемоторакс. Ургентно спрямований в операційну. Який метод фіксації кісткових фрагментів найдоцільніше застосувати в цій ситуації?

- А. Накістковий остеосинтез LCP-пластинами**
- В. Остеосинтез спицями Кіршнера**
- С. Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез**

- Д. ПХО. Триангулярна фіксація АЗФ на стрижневій основі**
- Е. ПХО. Лікування методом постійного скелетного витягання**

96. У яких площинах вимірює рухи методика визначення рухів в суглобах за системою SFTR?

- А. Сагітальна, фронтальна, трансверзальна, ротаційна**
- В. Пряма, поперечна, горизонтальна, осьова**
- С. Пряма, фронтальна, горизонтальна, ротаційна**
- Д. Сагітальна, фронтальна, горизонтальна, осьова**
- Е. Пряма, фронтальна, трансверзальна, ротаційна**

97. У травматологічне відділення переведено пацієнта з переломами передпліччя та стегнової кістки на 4 добу після ДТП. Загальний стан пацієнта задовільний. Показники життєво важливих функцій організму наближаються до нормальних. Який період травматичної хвороби у цього пацієнта?

- А. Термінальний стан**
- В. IV період**
- С. III період**
- Д. I період - гострий**
- Е. II період (нестійкої адаптації)**

98. Пацієнт віком 30 років шпиталізований до приймального відділення без свідомості, з діагнозом: кататравма. Які ключові методи діагностики потрібно застосувати для пацієнта?

- А. МРТ головного мозку**
- В. Рентгенографія кісток тазу**
- С. Рентгенографія органів грудної порожнини**
- Д. Урографія**
- Е. КТ-скринінг**

99. Укажіть рентгенометричну величину нормального кута нахилу 'даху' кульшової западини у дитини віком до 3-х міс.

- А. До 10°**
- В. До 40°**
- С. До 45°**
- Д. До 30°**
- Е. До 50°**

100. Військовий отримав кульове поранення в дистальну третину плеча. З

поверхні рани спостерігається витікання артеріальної крові. Що потрібно зробити для зупинки кровотечі?

- A. Накласти турнікет на рівні верхньої третини плеча. Рану закрити асептичною пов'язкою
- B. Накласти джгут на рівні верхньої третини плеча і тримати його протягом 6 год
- C. Накласти джгут на рівні ліктьового суглоба. Рану закрити тугою асептичною пов'язкою
- D. На рану накласти туго асептичну пов'язку
- E. Рану закрити тугою асептичною пов'язкою і максимально зігнути кінцівку у ліктьовому суглобі

101. Військовослужбовець під час бойового завдання отримав вогнепальне наскрізне уламкове поранення правого передпліччя. Лікування отримував на етапах медичної евакуації. Відповідно до чинної воєнної хірургічної доктрини, що роблять із первинним глухим швом після первинної хірургічної обробки у такого пацієнта?

- A. Накладають тільки на вихідний отвір
- B. Накладають тільки на вхідний отвір
- C. Накладають у перші 48 год з моменту поранення
- D. Накладають у перші 24 год з моменту поранення
- E. Не накладають

102. Що належить до транспортного дистракційного іммобілізаційного засобу?

- A. Шина Блека
- B. Вакуумні ноші
- C. Шина Томаса
- D. Шина Ларденуа
- E. Шина медична пневматична

103. Які клінічні прояви має вроджений вивих стегна у дітей до одного року?

- A. Асиметрія сідничних складок, укорочення ураженої кінцівки, відведення стегна менше 70°, колінний суглоб на стороні ураження нижче протилежного
- B. Асиметрія складок стегна, укорочення кінцівки, відведення стегна на 80°, розміщення коліна нижче від іншого
- C. Асиметрія складок стегна, укорочення кінцівки, відведення стегна на 70°, розміщення коліна вище від іншого

D. Асиметрія складок стегна, укорочення кінцівки, відведення стегна менше 70°, розміщення коліна вище іншого

E. -

104. Сержант віком 35 років отримав травму внаслідок дії вибухової хвилі, впавши на бік. Шпиталізований до медичної роти 2 год тому. У свідомості, скаржиться на біль у нижніх відділах живота, самостійно ходити не може, ноги підняти сам не може. Пульс - 104/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Живіт під час пальпації м'який, болючий в нижніх відділах, пальпується збільшений у розмірах сечовий міхур. Під час пальпації спостерігається різка болючість та крепітація в ділянці сідничних кісток та кісток лона. Симптом 'прилиплої п'яти' позитивний. Самостійно мочитися не може, на калитці спостерігається виражений набряк. Встановіть попередній діагноз.

- A. Розрив сечового міхура, перитоніт, перелом кісток тазу
- B. Розрив сечового міхура з пошкодженням уретри
- C. Перелом кісток тазу, розрив сечового міхура
- D. Перелом поперекового відділу хребта
- E. Перелом тазу, розрив уретри

105. До відділення політравми шпиталізований пацієнт після ДТП з діагнозом: політравма. Закрита травма живота. Розрив селезінки. Закритий перелом правої стегнової кістки (АО 3.3.C.3). Пацієнту виконано: лапаротомія, спленектомія, стабілізація перелому стегнової кістки апаратом зовнішньої фіксації. Планується металоостеосинтез (МОС) стегнової кістки пластиною та гвинтами. З анамнезу відомо, що пацієнт без супутньої патології, проте без призначення лікаря приймає клопідогрель в дозі 75 мг 1 р/д. Виберіть правильний варіант лікувальної тактики.

- A. Продовження прийому клопідогрелю, МОС стегнової кістки після стабілізації стану пацієнта
- B. Відміна клопідогрелю, призначення низькомолекулярного гепарину, МОС стегнової кістки не раніше ніж через 7 діб
- C. Відміна клопідогрелю, призначення низькомолекулярного гепарину, МОС стегнової кістки не раніше ніж через 21 добу

- D. Відміна клопідогрелю, МОС стегнової кістки не раніше ніж через 7 діб
- E. Продовження прийому клопідогрелю, призначення низькомолекулярного гепарину, МОС стегнової кістки після стабілізації стану пацієнта

106. Пацієнт віком 53 роки звернувся до лікаря зі скаргами на біль у ділянці хребта, який турбує його протягом останніх 3 міс, наявність пухлиноподібного утворення нижче пупартової зв'язки на лівому стегні, яке з'явилося близько тижня тому. Об'єктивно спостерігається: пацієнт ходить за допомогою милиць, під час пальпації визначається болючість та набряклість у ділянці остистих відростків хребців L1 та L2. На рентгенограмі в ділянці тіл першого та другого поперекових хребців спостерігаються осередки деструкції овальної форми, які носять контактний 'цілувальний' характер. Під час пункції пухлиноподібного утворення стегна евакуйовано 800 мл 'холодного гною'. Встановіть діагноз.

- A. **Туберкульозний спондиліт**
- B. Флегмона стегна
- C. Ілеофеморальний тромбоз
- D. Гематогенний остеомієліт стегна
- E. Остеогенна саркома стегнової кістки

107. Під час детального огляду пораненого встановлено локалізацію кровотечі з внутрішньої поверхні середньої третини плеча. Якою повинні бути подальші дії для зупинки кровотечі?

- A. **Оцінити, чи є кровотеча 'масивною', і залежно від результату використати необхідний метод**
- B. Застосувати тампонаду
- C. Використати оклюзійну пов'язку з одночасним застосуванням антибіотиків
- D. Накласти тиснучу пов'язку в ділянці середньої третини плеча
- E. Максимально швидко накласти турнікет за принципом 'максимально високо-максимально туго'

108. Дівчину віком 19 років шпиталізували після травми правого коліна під час катання на роликах. Пацієнтка розповідає, що відчула раптовий сильний біль у коліні під час падіння. Самостійно підвестися не змогла. Під час огляду виявлено набряк та деформацію правого коліна, обмеження під час спроби згинання-розгинання. Рентгенологічно спостерігається

уламковий перелом надколінка. Окрім введення анальгетиків, яке лікування рекомендовано пацієнтці?

- A. Артроскопія
- B. **Остеосинтез спицями і серкляжем**
- C. Закрите вправлення надколінка
- D. Відкрите вправлення надколінка
- E. Медіалізація горбистості великогомілкової кістки

109. У потерпілого під час землетрусу уламками зруйнованого будинку було здавлено обидві нижні кінцівки, які вдалося звільнити лише через 4 год. Розвиток якого патологічного процесу загрожує пацієнту?

- A. Гіперкоагуляції з поширеним тромбозом
- B. Фібринолізу
- C. **Гострої ниркової недостатності**
- D. Метаболічного алкалозу
- E. Септичного шоку

110. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на біль у ділянці лівого стегна, який посилюється вночі. Точно локалізувати місце болю він не може. За рекомендацією сімейного лікаря приймає 1 грам ацетилсаліцилової кислоти на ніч, що полегшує больові відчуття. На КТ лівого кульшового суглобу в ділянці дуги Адамса визначається просвітлення овальної форми, розмірами до 1 см, оточене смужкою склерозу. Кісткова тканина навколо гнізда пухлини не змінена. Який діагноз у цього пацієнта?

- A. Фіброзна дисплазія
- B. **Остеїд-остеома**
- C. Остеомієліт Гарре
- D. Остеогенна саркома
- E. Кісткова кіста

111. Пацієнт віком 40 років шпиталізований до відділення політравми після падіння з висоти 6 м. Після клініко-інструментального обстеження встановлено діагноз: поєднана торакальна, абдомінальна, скелетна травма; правобічний гемопневмоторакс, розрив селезінки, закриті переломи лонних кісток зі зміщенням фрагментів, розрив клубово-крижових зчленувань з обох сторін. З урахуванням діагнозу, яка черговість оперативних втручань показана пацієнту?

- A. Дренування плевральної порожнини за Бюлау, лапаротомія, функціональний метод лікування пошкодження тазу

- В. Лапаротомія, дренування плевральної порожнини за Бюлау, стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі
- С. Стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі, дренування плевральної порожнини за Бюлау, лапаротомія
- Д. Дренування плевральної порожнини за Бюлау, лапаротомія, стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі
- Е. Стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі, лапаротомія, дренування плевральної порожнини за Бюлау

112. Яких невідкладних заходів потрібно вжити для пацієнта віком 27 років, який отримав закритий перелом груднини, множинний односторонній перелом ребер від 2 до 6 праворуч, та у якого спостерігається напружений пневмоторакс?

- А. Дренування плевральної порожнини і стабілізація переломів груднини та ребер
- В. Загруднинна новокаїнова блокада
- С. Пункція плевральної порожнини
- Д. Введення анальгетиків
- Е. Штучна вентиляція легень

113. Яку кількість шин Крамера застосовують для транспортної іммобілізації при вогнепальному переломі стегнової кістки?

- А. 4
- В. 1
- С. 2
- Д. 5
- Е. 3

114. Що потрібно виконати як обов'язковий етап ПХО при вогнепальному пораненні з метою зменшення проявів компартмент-синдрому?

- А. Фасціотомію
- В. Провести накладення VAC-системи
- С. Провести некректомію
- Д. Накласти апарат зовнішньої фіксації
- Е. Не зашивати рану

115. Пацієнт віком 32 роки шпиталізований зі скаргами на нестерпний біль у правій кульшовій ділянці, різке обмеження опорно-кінематичної функції правої нижньої кінцівки. З анамнезу відомо, що травму отримав під час ДТП. Об'єктивно спостерігається: положення пацієнта вимушене, кінцівка у стані приведення, згинання в колінному суглобі з

внутрішньою ротацією. Під час пальпації виявлено: дефігурація в ділянці кульшового суглоба, позитивний симптом пружинної фіксації. Рухи в кінцівці різко підсилюють больовий синдром. Встановіть попередній діагноз.

- А. Закритий перелом дна вертлюгової западини справа
- В. Травматичний вивих кісток правої голівки
- С. Травматичний вивих голівки правої стегнової кістки
- Д. Асептичний некроз голівки правої стегнової кістки
- Е. Субкапітальний перелом голівки правої стегнової кістки

116. Під час огляду новонародженого виявлено деформацію правої стопи, яка перебуває у положенні еквінуса, супінації, аддукції, варуса. Вивести стопу в правильне положення не вдається. Встановіть найімовірніший діагноз.

- А. Плоско-вальгусна деформація стопи
- В. Спастична клишоногість
- С. Амніотичні перетяжки
- Д. Артрогрипоз
- Е. Правобічна вроджена клишоногість

117. Під час черезкісткового компресійно-дистракційного остеосинтезу в апараті зовнішньої фіксації дозована компресія не повинна перевищувати на добу:

- А. 0,3 см
- В. 0,8 см
- С. 1,5 см
- Д. 0,5 см
- Е. 1,0 см

118. Що таке спондилоартроз?

- А. Дегенерація фіброзного кільця міжхребцевого диску з його розривом і утворенням протрузії
- В. Процес осифікації міжхребцевих зв'язок
- С. Дегенеративний процес фіброзного кільця міжхребцевого диску
- Д. Дегенеративний процес міжхребцевого диску
- Е. Дегенеративний процес міжхребцевих суглобів хребта

119. Яка структура первинно залучається у дегенеративно-дистрофічний процес під час остеоартриту?

- А. М'язово-сухожильний комплекс

- В. Капсульно-зв'язковий апарат
- С. Субхондральна кістка
- Д. Синовіальна оболонка суглоба
- Е. Суглобовий хрящ

120. Що таке вторинний снаряд, що завдає ураження при мінно-вибуховому пошкодженні?

- А. Снаряд, який виник з навколишнього середовища внаслідок дії вибухової хвилі
- В. Снаряд, який виник внаслідок дії вибухового пристрою
- С. Снаряд, який виник внаслідок дії вибухової хвилі з вибухового пристрою
- Д. Снаряд, який виник при дії вибухового пристрою
- Е. -

121. Який метод лікування потрібно вибрати при переломі ліктьового відростка з розходженням уламків?

- А. Лікування скелетним витяганням
- В. Оперативне лікування (остеосинтез за Вебером)
- С. Фіксація гіпсовою пов'язкою в положенні розгинання в ліктьовому суглобі під кутом 140°
- Д. Імобілізація гіпсовою пов'язкою в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом 60°
- Е. Імобілізація гіпсовою пов'язкою в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом 90-100°

122. Чоловік віком 66 років був збитий електропотягом. Шпиталізований до відділення політравми із діагнозом: поєднана черепно-мозкова, торакальна, абдомінальна, скелетна травма, відкрита черепно-мозкова травма, інтракраніальна гематома, відкритий двобічний гемопневмоторакс, травматичний розрив печінки, селезінки. Травматичні ампутації обох нижніх кінцівок на рівні с/з стегон. Травматичний шок II-III ст. Бригадою політравми проведено підрахунок балів ISS - 66 балів. Якому ступеню травми відповідає цей результат?

- А. Вкрай важкому (травма несумісна з життям)
- В. Вкрай легкому
- С. Важкому
- Д. Середньому
- Е. Легкому

123. Укажіть післяопераційні реабілітаційні заходи, що абсолютно заборонені до використання у пацієнтки віком 69 років після планової процедури тотального ендопротезування колінного суглоба, що відбулася місяць тому з приводу остеоартриту III ст., на етапі амбулаторної реабілітації в умовах поліклініки.

- А. Опора на кінцівку, що була прооперована, без використання засобів додаткового опору
- В. Масаж оперованої нижньої кінцівки
- С. Магнітолазерні фізіопроцедури на прооперовану зону
- Д. Розробка рухів у прооперованому суглобі
- Е. Фізіопроцедури, що ґрунтуються на дії УВЧ на прооперовану зону

124. Поблизу військовослужбовця віком 40 років стався вибух, унаслідок якого його ліву нижню кінцівку притиснуло машиною. Звільнення кінцівки відбулося через 2 год, потерпілого евакуювали до стабілізаційного пункту. Під час огляду кінцівки спостерігається: шкіра блідо-ціанотичного кольору, набрякла, холодна на дотик. Об'єктивно спостерігається: тони серця приглушені, АТ - 80/60 мм рт. ст., пульс слабкого наповнення - 120/хв. Під час лабораторного дослідження сечі виявлено: міоглобін, протеїнурія, циліндрурія, колір сечі бурий. Встановіть діагноз.

- А. Гостра печінкова недостатність
- В. Синдром тривалого стиснення, період реконвалесценції
- С. Гострий гломерулонефрит
- Д. Синдром тривалого стиснення, період пізніх проявів
- Е. Синдром тривалого стиснення, гострий період

125. Коли здійснюють остеосинтез в умовах політравми при поєднанні пошкодження кісток опорно-рухової системи з травмою внутрішніх органів?

- А. Після операцій на внутрішніх органах і стабілізації життєвих функцій організму
- В. Одночасно з проведенням протишокових заходів
- С. Після стабілізації пораненого
- Д. Одночасно з оперативним втручанням з приводу пошкодження внутрішнього органу

Е. Одночасно з проведенням протишокових заходів та оперативним втручанням з приводу пошкодження внутрішнього органу

126. Що застосовують для черезкісткового позаосередкового компресійно-дистракційного остеосинтезу?

- А. Балки
- В. Гвинти
- С. Спиці 2 мм
- Д. Стрижні
- Е. Спиці 3 мм

127. Вкажіть метод зупинки масивної кровотечі у вузловій ділянці.

- А. Джгут
- В. Індивідуальний перев'язувальний пакет
- С. Туга тиснуча пов'язка
- Д. Турнікет
- Е. Тампонада

128. В яких структурах залягає первинний осередок специфічного запалення при туберкульозі кісток?

- А. Діафіз довгих трубчастих кісток
- В. -
- С. Кортикальний шар проксимального відділу довгих трубчастих кісток
- Д. Кістковий мозок трубчастих кісток
- Е. Метафіз та епіфіз довгих трубчастих кісток

129. Пацієнт віком 66 років скаржиться на біль та обмеження рухів у правому кульшовому суглобі. Під час огляду виявлено: незначна атрофія м'язів правого стегна та обмеження всіх рухів у суглобі (привідні контрактури). Пацієнту рекомендоване ендопротезування правого кульшового суглоба. Що з наведеного не є показанням до ендопротезування кульшового суглоба?

- А. Остеоартрит кульшових суглобів I-II стадії
- В. Остеоартроз кульшових суглобів (коксартроз) III-IV стадії
- С. Асептичний некроз голівки стегнової кістки
- Д. Хвороба Бехтерева з переважним ураженням кульшових суглобів
- Е. Незрощені переломи і хибні суглоби після перелому голівки стегнової кістки

130. Сержант віком 45 років внаслідок руйнування будинку отримав множинні

травми: синдром тривалого стиснення обох нижніх кінцівок, множинні переломи кісток обох гомілок, переломи обох стегнових кісток. Постраждалого витягнуто з-під уламків будинку через 6 год, на місці катастрофи накладено турнікети на обидві нижні кінцівки на рівні верхньої третини стегна. Під час огляду спостерігається: шкірні покриви бліді, АТ - 100/30 мм рт. ст., пульсація на а. dorsalis pedis після зняття джгутів не визначається, тактильна і больова чутливість у дистальних відділах нижніх кінцівок відсутня, активні та пасивні рухи в колінних та над'яtkово-гомілкових суглобах неможливі. Яка тактика лікування?

- А. Термінова ампутація обох нижніх кінцівок вище джгута
- В. Гіпербарична оксигенація
- С. Детоксикаційна інфузійна терапія, форсований діурез
- Д. Стабілізація переломів нижніх кінцівок, протишокові заходи
- Е. Інфузійна терапія з метою стабілізації артеріального тиску

131. На I етапі медичної евакуації шпиталізовано важкопораненого військовослужбовця віком 36 років (водій БМП). Із анамнезу встановлено, що під час штурмових дій потерпілий наїхав на протитанкову міну 3 год тому. Загальний стан тяжкий. Об'єктивно виявлено: шкірні покриви та слизові оболонки бліді, холодні на дотик, свідомість потьмарена, АТ - 80/50 мм рт. ст., ЧСС - 120/хв, ЧД - 20/хв. Індекс Альговера - 1,5. Локально спостерігається: відкриті множинні переломи плеснової та заплеснової кісток, н/3 обох кісток гомілок з обох сторін. Обидві стопи холодні на дотик. Пульсація на артеріях стоп не визначається. Відповідно до шкали MESS якою є імовірність подальшої ампутації у цього пораненого?

- А. 30%
- В. 50%
- С. 40%
- Д. 100%
- Е. 70%

132. У пацієнтки, хворої на гонартроз, після внутрішньосуглобового введення флостерону через тиждень посилюється біль у суглобі, він збільшився в об'ємі, з'явилася згинальна контрактура. Яку патологію можна запідозрити і яку лікувальну тактику обрати в цьому разі?

- A. Неспецифічний артрит, зробити пункцію суглобу, посіяти його вміст на наявність мікроорганізмів, промити суглоб антисептичним розчином, призначити антибіотики після виявлення мікробного росту
- B. Загострення артрозу, зробити пункцію суглоба, призначити лікування антибіотиком широкого спектру дії
- C. Загострення артрозу, призначити протизапальну фізіотерапію
- D. Загострення артрозу, призначити протизапальну терапію
- E. Загострення артрозу, провести іммобілізацію суглоба

133. Жінка віком 44 роки потрапила у ДТП (пасажирка). Шпиталізована до відділення політравми з діагнозом: ЗЧМТ, забій головного мозку легкого ступеня, закриті переломи II-IV ребер зліва. Закритий неускладнений компресійний перелом тіла хребця Th12 I ст. Бригадою політравми проведено підрахунок балів ISS - 12 балів. Якому ступеню травми відповідає цей результат?

- A. Вкрай важкому
- B. Легкому
- C. Важкому
- D. Середньому
- E. Незначному

134. Яким кольором під час медичного сортування позначаються пацієнти, що потребують невідкладних оперативних втручань?

- A. Чорним
- B. Сірим
- C. Зеленим
- D. Жовтим
- E. Червоним

135. Чоловік віком 40 років у дорожньо-транспортній пригоді отримав перелом стегнової кістки в нижній третині зі значним зміщенням фрагментів. Розвиток якого ускладнення варто передбачити під час лікування пацієнта?

- A. Гемартроз колінного суглоба
- B. Посттравматичний неврит сідничного нерва
- C. Здавлення судинно-нервового пучка
- D. Зрощення перелому у неправильному положенні
- E. Контрактура колінного суглоба

136. Пацієнт віком 50 років шпиталізований до реанімаційного відділення після ДТП з діагнозом: закритий переломи діафізів обох стегнових кісток, розрив селезінки, травматичний шок III ст. Які оперативні втручання повинні проводитись згідно з тактикою 'Damage control'?

- A. Спленектомія. Остеосинтез АЗФ
- B. Спленектомія. Скелетне витягіння
- C. Спленектомія. Гіпсові пов'язки
- D. Спленектомія. Інтрамедулярний остеосинтез
- E. Стабілізація загального стану пацієнта

137. Військовослужбовець, поранений у ділянці гомілки, у 'червоній зоні' через наявність ознак масивної кровотечі, в якості самопомогі наклав на поранену нижню кінцівку турнікет за принципом 'максимально високо-максимально туго'. Що необхідно зробити для зменшення проявів турнікетного синдрому та зменшення зони ішемії?

- A. Перевірити турнікет і затягнути сильніше з одномоментним накладенням тугої тиснучої пов'язки
- B. Розпускати турнікет кожні 30 хв, а через 2 год зняти турнікет
- C. Накласти туго пов'язку і зняти турнікет через 1 год після його накладення
- D. Через 30 хв розпустити турнікет на 10 хв і повторно затягнути
- E. Виконати конверсію турнікету

138. У пацієнтки діагностовано відкритий перелом середньої третини діафізу кісток гомілки зі зміщенням уламків. Рана 7 см з масивним забоєм м'яких тканин. Укажіть, який метод лікування рекомендовано у цьому разі.

- A. Закрита репозиція, гіпсова іммобілізація
- B. Відкрита репозиція, накістний остеосинтез
- C. Відкрита репозиція, інтрамедулярний остеосинтез
- D. Черезкістковий позаосередковий компресійно-дистракційний остеосинтез
- E. Скелетне витягіння

139. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на постійний біль у шийному відділі хребта та відчуття оніміння в лівому плечі, які посилюються під час фізичних навантажень. Під час обстеження

відзначаються обмеження рухів та напруження м'язів шийного відділу хребта, слабкість лівої руки. На МРТ виявлено звуження міжхребцевої щілини хребців С3–С4, наявність випинання диска С3–С4 до 2 мм, зміщення тіла хребця С4 становить 3 мм допереду. Встановіть діагноз.

- А. Деформуючий спондиліоз шийного відділу хребта
- В. Виражена нестабільність на рівні хребців С3–С4
- С. Міозит
- Д. Кила диска хребців С3–С4 з нестабільністю хребця на цьому рівні
- Е. Кила диска хребців С3–С4

140. Внаслідок вибуху цистерни з бензолом на хімічному заводі є загиблі та поранені у великій кількості (понад 50 осіб) з опіками, механічними травмами та отруєннями. Вкажіть основні елементи, які передбачає лікувально-евакуаційне забезпечення в цій ситуації.

- А. Ізоляція, рятування, відновлення
- В. Сортування, відновлення, рятування
- С. Сортування, евакуація, лікування
- Д. Сортування, надання первинної медичної допомоги, евакуація
- Е. Надання медичної допомоги, евакуація, ізоляція

141. Який спосіб фіксації доцільно застосовувати в разі перелому голівки з незначним зміщенням уламків, який супроводжується компартмент-синдромом?

- А. Апаратом зовнішньої фіксації
- В. Накістковою пластиною
- С. Гіпсовою шиною
- Д. Інтрамедулярним блоковим стрижнем
- Е. Накістковою мостовидною пластиною

142. Укажіть рентгенологічні ознаки, які можуть вказувати на злоякісну пухлину кістки.

- А. Остеофіти, звуження суглобового просвіту, субхондральний остеосклероз, деформація суглобових поверхонь кістки
- В. Нерівні та нечіткі контури осередка, розвиток деструкції кістки, локалізація у метафізі
- С. Контури рівні, без ознак руйнування навколишніх тканин, рівномірна структура та щільність, відсутність

остеолізу, облямівка остеосклерозу, відсутність інвазії в сусідні тканини

- Д. Прогресуюча прозорість центру тіл хребців, зменшення щільності кісткової тканини, збільшення порожнин у кістці, патологічний перелом
- Е. Симетричне ураження парних дрібних суглобів, навколосуглобовий остеопороз, звуження суглобових проміжків, контрактури, анкілоз

143. До лікарні шпиталізовано пацієнта віком 32 роки. Діагноз: політравма, за шкалою ISS - 25 балів, відкритий II ст. перелом кісток середньої третини правої стегнової кістки. Коли потрібно проводити стабілізацію та остеосинтез перелому?

- А. Інтрамедулярний остеосинтез в I добу
- В. Остеосинтез пластиною в I добу
- С. Скелетне витягіння, заміна методу фіксації через 3 тижні
- Д. АЗФ, як остаточний метод лікування
- Е. Стабілізація АЗФ в I добу, заміна методу фіксації після 10 доби

144. Що включають у себе клініко-рентгенологічні прояви у спондилітичній фазі патогенезу туберкульозного спондиліту?

- А. -
- В. Порушення функції хребта
- С. Виражені трофічні порушення хребців
- Д. Руйнування хребців та деформацію хребта
- Е. Утворення двошарової порожнини абсцесу в навколишніх м'яких тканинах

145. Укажіть правильну послідовність рентгенологічної ознаки асептичного некрозу голівки стегнової кістки.

- А. Осередка висвітлення кісткової тканини, осередка остеопорозу, остеосклерозу
- В. Нерівномірне звуження суглобової щілини, крайові кісткові розростання
- С. Поширені кісткові розростання, ознаки остеолізу
- Д. Розширення суглобової щілини, порушення контурів голівки стегнової кістки
- Е. -

146. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на біль у лівому стегні, який з'явився близько тижня тому. З анамнезу відомо: хворіє на хронічний остеомієліт лівого стегна

протягом 10-ти років після уламкового поранення. Об'єктивно спостерігається: на зовнішній поверхні стегна є кілька кратероподібних втягнутих і лінійних рубців як наслідок нориць і перенесених оперативних втручань. Також спостерігається ділянка гіперемії шкіри, набряклість та болючість цієї ділянки, у центрі пальпованого інфільтрату наявне розм'якшення. Температура тіла - 37,8°C. На рентгенограмі в дистальному метафізі стегнової кістки визначається порожнина з вільно лежачим секвестром 1,5x2 см. Якою повинна бути подальша тактика лікування?

- A. Вактерапія, антибіотикотерапія
- B. Ультразвукова кавітація секвестральної порожнини
- C. Фістулосеквестрнекректомія
- D. Антибіотикотерапія, перев'язки щодня
- E. Апарат Ілізарова, антибіотикотерапія

147. У пацієнта віком 38 років після дорожньо-транспортної пригоди діагностовано закритий перелом обох стегнових кісток, забій головного мозку, тупа травма живота, шок III ст. Визначте актуальну тактику лікування.

- A. Протишокова терапія, скелетне витягання за обидві стегнові кістки
- B. Протишокова терапія, інтрамедулярний остеосинтез обох стегнових кісток
- C. Протишокова терапія, накістковий остеосинтез обох стегнових кісток
- D. Протишокова терапія, стабілізаційний апарат зовнішньої фіксації
- E. Накістковий остеосинтез обох стегнових кісток в ургентному порядку

148. Пацієнта, що отримав травми внаслідок ДТП (водій мотоцикла), доправлено до приймального відділення політравми з ознаками нестабільної гемодинаміки. Після клінічно-інструментально обстеження та проведених заходів інтенсивної терапії в умовах операційної встановлено діагноз: поєднана травма. Закрита травма грудної клітки. Перелом VI, VII, VIII ребер справа. Відкритий II ст. (Gustilo-Anderson) уламковий перелом н/з правої стегнової кістки. Розрив лонного зчленування. Закритий трансфорамінальний перелом крижової кістки справа. Закритий вивих лівого стегна. Забійно-рвана рана лівої гомілки. Геморагічний шок III ст. Виберіть пріоритетну лікувальну процедуру в цьому клінічному випадку.

- A. Стабілізація тазового кільця
- B. Стабілізація перелому правої стегнової кістки
- C. ПХО ран правої стегна та лівої гомілки
- D. Дренування правої плевральної порожнини за Бюлау
- E. Усунення вивиху лівого стегна

149. До лікаря-травматолога звернулись батьки чотиримісячного хлопчика. Під час огляду виявлено помірний нахил голови ліворуч та поворот обличчя до протилежного боку. Визначається обмеження рухів у шийному відділі хребта. Лівий груднино-ключично-соскоподібний м'яз щільний і скорочений. У черевці м'язу пальпуються окремі щільні вузли. Встановіть попередній діагноз.

- A. Спастичний параліч
- B. Дисплазія шийного відділу хребта
- C. Наслідки перелому ключиці під час пологів
- D. В'ялий параліч
- E. М'язова кривошия

150. На етап спеціалізованої допомоги шпиталізовано військовослужбовця з уламковим сліпим проникним пораненням правої колінної суглоба. Під час огляду спостерігається: рана на медіальній поверхні колінної суглоба, у проєкції медіального виростка стегнової кістки, розміром 5x3 см, дно рани заповнюють кісткові фрагменти. Наявні Ro-ознаки уламкового перелому правої надколінки зі зміщенням фрагментів, дефект кісткової тканини надколінки, стороннє металеве тіло порожнини правої колінної суглоба. Яка лікувальна тактика найдоцільніша у цьому разі?

- A. ПХО, напружений металоостеосинтез перелому надколінки, рана зашивається, встановлюється система проточно-промивного дренування колінної суглоба, перев'язки рани з розчинами антисептиків
- B. ПХО, рана зашивається, перев'язки рани з розчинами антисептиків
- C. ПХО, накладається шов на капсулу суглоба, інші м'які тканини не ушиваються, встановлюється система проточно-промивного дренування колінної суглоба, іммобілізація перелому задньою гіпсовою шиною, перев'язки рани з розчинами антисептиків

- D.** Туалет рани ведеться відкритим методом
- E.** ПХО, напружений металоостеосинтез перелому надколінка, рана не зашивається, перев'язки з розчинами антисептиків